

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

MALT · MÜNCHNER ALKOHOLISMUS TEST

Test Münchner de Alcoholismo – Sistema mixto médico-conductual para la confirmación diagnóstica de la dependencia alcohólica

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial	Münchner Alkoholismus Test (MALT / Test de Munich para el Alcoholismo)
Autores Originales	Wilhelm Feuerlein, C. Ringer, K. A. Küfner y H. Busch (1977)
Validación Española	Helena Rodríguez-Martos et al. (1986); Banco de Instrumentos de Bobes et al. (2004)
Tipo de Instrumento	Instrumento mixto: examen médico objetivo (MALT-M) + cuestionario autoinformado (MALT-S)
Población Diana	Pacientes adultos con sospecha de consumo perjudicial o adicción al alcohol
Tiempo de Aplicación	10 a 15 minutos en total (5 min parte médica, 8 min autoinforme)
Formato de Respuesta	MALT-M: 7 ítems clínicos valorados por el facultativo; MALT-S: 24 ítems dicotómicos Sí/No
Finalidad Clínica	Diagnóstico nosológico preciso de la dependencia alcohólica, minimizando el impacto del sesgo de negación o minimización del paciente mediante hallazgos biológicos objetivos

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO TEÓRICO

El diagnóstico temprano del alcoholismo tropieza frecuentemente con dos escollos metodológicos contrapuestos: los autoinformes puramente subjetivos son vulnerables a la simulación, minimización o falta de conciencia de enfermedad del paciente, mientras que los análisis bioquímicos aislados (transaminasas, VCM) adolecen de falta de especificidad o se normalizan con breves períodos de abstinencia.

Para resolver este dilema, el equipo del Instituto Max Planck de Múnich, liderado por Feuerlein, concibió el MALT como una herramienta diagnóstica combinada que fusiona dos fuentes de información ortogonales: a) **MALT-Médico (MALT-M)**, compuesto por 7 parámetros clínicos objetivos evaluados por el facultativo (hepatomegalia, telangiectasias, temblor lingual/manual, feto, polineuropatía y analítica); y b) **MALT-Subjetivo (MALT-S)**, compuesto por 24 preguntas respondidas por el paciente sobre conductas de consumo, pérdida de control, amnesias alcohólicas y problemas psicosociales.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS

Sección del MALT	Nº Ítems	Contenido Clínico y Metodología de Registro
MALT-Médico (MALT-M)	7 ítems	Exploración física y laboratorio: esteatosis/hepatomegalia, arañas vasculares, temblor fino de lengua o dedos, polineuropatía periférica, pancreatitis previa y alcohol aliento.
MALT-Subjetivo (MALT-S)	24 ítems	Autoinforme de consecuencias psicosociales: beber en ayunas, necesidad imperiosa de beber (craving), lagunas amnésicas (blackouts), culpa, conflictos conyugales y laborales.
Puntuación Total MALT	31 ítems	Suma ponderada de MALT-M + MALT-S (Rango: 0 a 43+ puntos).

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMACIÓN Y REGLAS DE CORRECCIÓN · MALT

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATINOAMÉRICA

Sensibilidad y Especificidad	Con punto de corte total ≥ 11 : Sensibilidad = 94%, Especificidad = 92%, Área Bajo la Curva ROC = 0.96 frente a diagnóstico CIE-10/DSM-IV de dependencia del alcohol (Rodríguez-Martos et al., 1986).
Consistencia Interna	Alfa de Cronbach de la subescala MALT-S = 0.86 a 0.89 en muestras clínicas ambulatorias e internadas en España.
Fiabilidad Test-Retest	Coeficiente de correlación intraclass ICC = 0.88 en intervalos de 1 a 2 semanas en pacientes desintoxicados.
Validez Concurrente	Correlación sobresaliente con el MAST ($r = 0.84$), con el CAGE ($r = 0.79$) y con determinaciones de CDT y GGT séricas.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

- Ponderación de la Sección Médica (MALT-M):** Cada signo físico o analítico tiene una ponderación de **1 a 4 puntos** según su gravedad y especificidad patológica (p. ej., cirrosis confirmada o polineuropatía alcohólica suman 4 puntos).
- Ponderación de la Sección Autoinforme (MALT-S):** Los 24 ítems se puntúan:
 - Mayoría de ítems afirmativos ("Sí") = **1 punto**.
 - Ítems nucleares de dependencia severa (beber por la mañana, delirium previo) = **2 puntos**.
- Cálculo Total:** Puntuación Total = Subtotal MALT-M + Subtotal MALT-S.
- Regla Diagnóstica Categorical:** La puntuación total se interpreta en una escala de tres tramos diagnósticos oficiales.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Puntuación Total	Diagnóstico MALT	Probabilidad Alcoh.	Directriz Asistencial y Clínica
0 a 5 puntos	No Alcohólico	Muy Baja ($< 5\%$)	Ausencia de criterios de adicción. Seguimiento habitual.
6 a 10 puntos	Sospecha de Alcoholismo	Intermedia (40-50%)	Consumo de riesgo o fase prodrómica; reevaluación clínica.
≥ 11 puntos	Alcoholismo Confirmado	Extrema ($> 95\%$)	Diagnóstico certero de Dependencia Alcohólica; plan deshabituación.

VALOR DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA MALT: Si un paciente intenta simular normalidad negando los 24 ítems del MALT-S (obteniendo 0 puntos), la presencia de hepatomegalia dura, estigmas cutáneos y polineuropatía en el MALT-M puede sumar por sí sola más de 11 puntos, confirmando objetivamente el diagnóstico de alcoholismo crónico.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y DIRECTRICES · MALT

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA E INTERVENCIÓN

Paso 1: Exploración Física y Entrega del Autoinforme: Cumplimentar los 7 ítems médicos por el facultativo y solicitar al paciente que responda el MALT-S.

Paso 2: Conducta Asistencial:

- **Si Total 0-5:** Descartar dependencia alcohólica activa.
- **Si Total 6-10:** Situación de alerta. Indicar analítica con transaminasas, GGT y ecografía abdominal; realizar entrevista motivacional para reducción de consumo.
- **Si Total ≥ 11 :** Diagnóstico firme de alcoholismo.
 1. Evaluar gravedad de la abstinencia física con escala EIDA o CIWA-Ar.
 2. Planificar desintoxicación supervisada con benzodiazepinas y complejo vitamínico B.
 3. Derivación formal a Centro de Atención a las Drogodependencias (CAD) para psicoterapia de prevención de recaídas y valorar anticraving (acamprosato, naltrexona).

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO (VIGNETTE)

Identificación: Varón de 51 años, fontanero, ingresado en el servicio de medicina interna por dolor epigástrico irradiado en cinturón y vómitos biliosos. En la anamnesis niega tener problemas con la bebida ("bebo lo de todo el mundo").

Evaluación Psicométrica Inicial en MALT:

- **MALT-Médico (MALT-M):** 9 puntos. Se constata hepatomegalia sensible de 3 traveses de dedo (2 puntos), arañas vasculares en tórax (1 punto), temblor lingual al protruir (2 puntos) y antecedente de pancreatitis aguda alcohólica actual (4 puntos).
- **MALT-Subjetivo (MALT-S):** 7 puntos. Aunque minimizó, admitió beber cerveza a primera hora para calmar el estómago (2 puntos), discusiones familiares recurrentes por el alcohol (1 punto) y dos episodios de amnesia tras fiestas (2 puntos).

Puntuación Total MALT: 16 puntos (Alcoholismo Confirmado, muy por encima del corte de 11).

Intervención: La evidencia objetiva de los 9 puntos médicos desactivó la negación del paciente durante la interconsulta psiquiátrica hospitalaria. Se pautó desintoxicación con diazepam oral y tiamina intramuscular, con resolución de los síntomas gastrointestinales. Al alta médica fue vinculado al programa ambulatorio de deshabitación alcohólica con acamprosato oral, alcanzando 12 meses de abstinencia continuada.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

ALERTAS CLÍNICAS VITALES

- Puntuaciones altas en MALT-M alertan de daño hepático avanzado o encefalopatía; no demorar la administración parenteral de tiamina.
- La retirada brusca en pacientes con MALT ≥ 11 sin protección de benzodiazepinas puede desencadenar Delirium Tremens a las 48-72 horas.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

- **Hepatopatía No Alcohólica (NASH):** Hepatomegalia y esteatosis en sujetos obesos o diabéticos sin consumo patológico en MALT-S.
- **Trastorno Afectivo Bipolar:** Consumo compulsivo secundario a fase maníaca desinhibida; explorar eutimia interepisódica.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

- Feuerlein, W., Ringer, C., Küfner, H., & Busch, H. (1977). Diagnose des Alkoholismus: Der Münchner Alkoholismustest (MALT). *Münchener Medizinische Wochenschrift*, 119(40), 1275–1282.
- Rodríguez-Martos, A., Navarro, R. M., & Vecino, C. (1986). Validación del Münchner Alkoholismus Test (MALT) en población española. *Revista de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de Barcelona*, 13(3), 121–130.
- Feuerlein, W., Küfner, H., Ringer, C., & Antons, V. (1980). The Munich Alcoholism Test (MALT): Results of validation. *Drug and Alcohol Dependence*, 6(1), 65–72.
- Bobes, J., García-Portilla, M. P., Bascarán, M. T., Sáiz, P. A., & Bousoño, M. (2004). *Banco de instrumentos básicos para la práctica de la psiquiatría clínica* (3.ª ed.). Ars Médica.